



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : صفاء حفطى ادم ابراهيم

العنوان :

الحي / المدينة : البساتين

المحافظة : القاهرة

مهممممممممممممممممممممممم

تاريخ تسجيل الإستمارة : 01-10-2026

رقم البطاقة : 27602050104429 رقم التليفون : 01142971677

العمر(تاريخ الميلاد) : 05-02-1976 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي محوسب مع صبغة للصدر والبطن

قسم العلاج :
الأورام

والحوض [11129]

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني

الاسم : د/ندى حسن

الاسم : د/نرمين رمضان

الوظيفة :

الوظيفة :

الوظيفة :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... /د. /د. /د. /د. /د. /د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

قسم :

جهة العلاج :

نفقات :

ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: صفاء حنفى ادم ابراهيم National ID: 27602050104429	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Contrast-enhanced CT scan of the chest, abdomen, and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

صفاء
حفظى آدم ابراهيم
١٤ ش مصطفى كامل - ش على عبدالعزيز
الهيكلين - القاهرة

٢٧٦.٢.٥.١.٤٤٢٩

KB7806798

٢.٢٣/٠٧ ٢٧٦.٢.٥.١.٤٤٢٩
ربة منزل
أنثى
متزوجة
احمد معروف ابراهيم سالمان
البطاقة سارية حتى ٢٠٣٠/٠٧/٢٥

١

Name : Safaa Hafzy Adam Ibrahim
Branch : Dokki

Date : 22-12-2025 11:23
Medical No. : 279071

Tc^{99m} MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

History

- A 49-year-old lady, with history of left breast cancer and referred for metastatic workup.

Technique

- Anterior and posterior whole-body scans were acquired 2 hours post injection of the tracer.

Findings

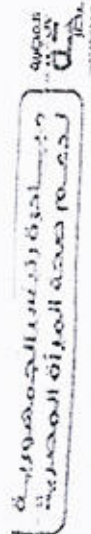
- No abnormal active or cold focal bony lesions that could account for metastatic bone disease.
- Degenerative changes are noted at the spine and big joints.

Impression:

- The skeleton is free from metastases.

Best regards,
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear Medicine

Name: _____ MR. : 4800	صفاء حفظ آدم
Detailed Medical Report	
السيد	
تحية طيبة وبعد,,	
	إيماء للطلب المقدم من
	بشأن تقرير طبي للمريض
	رقم طبي:
بقسم:	
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالتها	
	تاريخ وساعة الدخول :
	تاريخ وساعة الخروج :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها MRI lumbar spine revealed disc protrusion at L2/3, L3/4, and L4/5; orthopaedic or neurosurgical consultation was scheduled today for femara, with supportive treatment for 3 months. ZOLADex to be taken on 10/5/2026; ZOMETA to be started after dental assessment. Femara plus supportive therapy for 3 months; next clinic visit scheduled 30/8/2026. The patient, a 50-year-old female with no comorbidities, has a family history of cT4b N2 IDC GII ER 8/8 PR 8/8 HER2-negative. She received neoadjuvant chemotherapy with AC for 4 cycles and taxane for 4 cycles, followed by left total mastectomy and sentinel lymph node biopsy. Pathology showed ypT2 ypN1. She underwent post-operative radiotherapy and has been on an aromatase inhibitor plus ZOLADex since August 2021. After consultation with Dr. Khaled, the multidisciplinary team discussed continuing tamoxifen for another 5 years, continuing femara with supportive treatment for 3 months, and BSM with CT CAP. Annual assessment is planned.	
تحريراً في ,	
	التاريخ : 20-09-2026
	الوقت :
الطبيب المعالج :	
Reham Ahmed Fathy Ibrahim	
يعتمد ,	



Fort Fort

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]



Immunohistochemistry report

Report Number: m1059

Female	نوع	مساء حاضري يوم	دور الحوض
17/02/2020 14:46	التاريخ	42 Y	تسلسل
19/02/2020 09:50	تاريخ السليم التاريخ	مسحة لغزو	تاريخ الخزعة
	تاريخ الخزعة	مسحة لغزو	مسحة الخزعة

Primary Sample

Paraffin Block

Test

ER & PR & HER2 neu & Ki67 (ER & PR Harvey scoring system - Her2 neu CAP scoring system)

Comment

Technique

sample received was treated by - CONFIRM anti-estrogen (ER) (SP1) Rabbit monoclonal primary antibody - CONFIRM anti-progesterone receptor (PR) (IE2) Rabbit monoclonal primary antibody
Sample received was treated by - JENTANA anti-HER2 neu (485) Rabbit monoclonal primary antibody using DAB Detection kit in Ventana benchmark GX

Sample received was treated by - CONFIRM anti-Ki67 (30-9) Rabbit monoclonal primary antibody

Result

ER strong nuclear staining of > 60 % of tumour cells (core biopsy)

PR strong nuclear staining of > 60 % of tumour cells (core biopsy)

HER2/neu protein over expression - No membrane staining of tumour cells (core biopsy)

Ki67 positive nuclear staining of 60-70 % of tumour cells (core biopsy)

Referral Lab

Comment

Conclusion

ER POSITIVE (SCORE 8+)

PR POSITIVE (SCORE 8+)

HER2/NEU PROTEIN OVER EXPRESSION - NEGATIVE

Ki67 THE PROLIFERATION INDEX OF THE TUMOUR IS 60-70 %

Pathologist

التوقيع

Lab Director

Patient Name : 27602050104429
Patient No : 1806
Path No : Female
Sex : 45 Y
Age : 45 Y
Referring Doc :
Request No. : 138466
Request Date : 17/08/2021
Verification Date : 23/08/2021
Financial Category : Out Patient
Department : Out Patient

Pathology Report

Clinical Data: post chemo breast cancer

Nature of the specimen: MRM
Gross Examination: MRM measure 25x16x3 cm, covering skin 18x13 cm, nipple, areola unremarkable, skin show dimpling under it a grayish white mass.

- Procedure: MRM
- Localization: Left
- Tumor extent
 - o Number: one
 - o Size: 3x2x2 cm
 - o Skin involvement: no
- Distance from margins: 2 cm from the deep one
- Lymph nodes number and size: 12 LNs, up to 2cm in diameter

Microscopic examination:

- Histological type: invasive duct carcinoma
- Grade (differentiation): nuclear pleomorphism + mitosis: G1
- Angiolysis: yes
- Ductal carcinoma in situ: Yes <5%
- Lymph node involvement: 1/12
- Resection Margins: free
- Histologic response to therapy: partial
- Additional pathologic findings:

Diagnosis:

Localization: Procedure: Left medial radical mastectomy
• Histological type: Tumor grade: invasive duct carcinoma, grade II
Partial pathological response
free nipple, skin and deep margin
positive lymphovascular emboli
No perineural invasion
Tumor necrosis index: 4/5%

Patient Name : 27602050-04429
Patient No. : 1905
Path No. : Female
Sex : 45 Y
Age :
Referring Doc :
Request No. : 135466
Request Date : 17/08/2021
Verification Date : 23/08/2021
Financial Category : Out Patient
Department :
تورم باطن السلام - منطقة الدوحة

Pathology Report

lymph node sistus 1.12
yp12 ypN1 ypM/x

Prof. Dr. Lubna Omar
Dr. Mona Mohamed

Patient Name: Safaa Hafzy Adam Ibrahim	Date : 11/06/2024
Exam : C.T. ABDOMEN & PELVIS WITH	Age : 48 Year(s)
CONTRAST	
Medical ID: 4734/2020	Pat. ID: 13842

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED:-

Compared to the previous study dated 02-10-2023 the current study shows:

1. Chest:

- Left mastectomy with operative bed distortion.
- Still noted prominent left internal mammary lymph node measuring 5 mm.
- Still noted prominent left supra-clavicular lymph nodes the largest measures 9 X 8 mm.
- Still noted few bilateral scattered pulmonary nodules ranging from 2-3 mm.
- Left upper lung lobe radiation pneumonitis.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. Abdomen and pelvis:

- Enlarged liver with no hepatic focal lesion detected.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals (apart from right adrenal hypodense focal lesion measures 1.4 x 1.7 cm likely adenoma).
- IUG seen in place.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or

Patient Name: Safaa Hafzy Adam Ibrahim	Date: 11/06/2024
Exam: C.T. ABDOMEN & PELVIS WITH CONTRAST	Age: 48 Year(s)
Medical ID: 4734/2020	Pat. ID: 13642

- Further more sclerosis regarding the previously mentioned manubrium sternal lytic lesion with cortical breaching.
- Left femoral head, acetabular roof and anterior acetabular sclerotic foci mostly bone islands.

OPINION:

Status follow up showing:

- *Further more sclerosis of the sternal metastatic lesion.*
- *overall stationary course of the rest of the study.*

Dr. Mohammed Mohsen, M.D

Signature Dr. Mohamed Mohsen

20/06/2024 09:28